# 医科歯科連携マニュアル

## 双方向照会状・照会基準・QA集

令和6年度診療報酬改定対応版

**収録内容**


第1章　こんな患者が来たら連携しよう（チェックリスト）

第2章　意外と深い！口腔と全身疾患の関わり

第3章　すぐ使える照会状・紹介状テンプレート（4種）

第4章　診療報酬点数の整理

第5章　医師向けQA集（全16問）

付　録　糖尿病ガイドラインCQ一覧表

# 目　次


第1章　**こんな患者が来たら連携しよう** ..... 3

1-1 医師→歯科：こんな患者は歯科へ ..... 3

1-2 歯科→医師：こんな患者は医師へ ..... 4

第2章　**意外と深い！口腔と全身疾患の関わり** ..... 5

2-1 糖尿病と歯周病の双方向性 ..... 5

2-2 脳卒中・動脈硬化 ..... 6

2-3 認知症（アルツハイマー型） ..... 6

2-4 骨粗鬆症とMRONJ ..... 7

2-5 睡眠時無呼吸症候群（SAS） ..... 7

2-6 誤嚥性肺炎・周術期口腔機能管理 ..... 8

第3章　**すぐ使える照会状・紹介状テンプレート** ..... 9

3-1 書類の種類と使い分け ..... 9

3-2 テンプレート①：医師→歯科（周術期口腔機能管理） ..... 9

3-3 テンプレート②：歯科→医師（糖尿病患者の外科処置前） ..... 10

3-4 テンプレート③：歯科→医師（MRONJ予防） ..... 11

3-5 テンプレート④：歯科→医師（SAS疑い） ..... 12

第4章　**診療報酬点数の整理** ..... 13

第5章　**医師向けQA集（全16問）** ..... 14

付　録　**糖尿病ガイドラインCQ一覧表** ..... 18

# 第1章　こんな患者が来たら連携しよう（チェックリスト）

## 1-1　医師→歯科：こんな患者は歯科へ照会しよう

### ▶ 術前・治療前

- 全身麻酔手術（心臓・肺・消化器・頭頸部など）予定の患者
- 放射線治療（特に頭頸部）予定の患者
- ビスフォスフォネート・デノスマブ等の骨吸収抑制薬投与開始前の患者
- 造血幹細胞移植予定患者

### ▶ 全身疾患管理中

- 糖尿病（特にHbA1c 7.0%以上でコントロール不良）
- 狭心症・心筋梗塞・心不全・人工弁・感染性心内膜炎リスク患者
- 慢性腎不全・血液透析中の患者
- 脳梗塞・脳出血（急性期後の口腔ケア維持含む）
- 骨粗鬆症で骨吸収抑制薬使用中（または開始予定）

### ▶ 日常観察から気づく

- 腔内の問題を訴えているが自院での対応が困難
- 認知機能低下・咀嚼・嚥下障害がある患者
- 睡眠時無呼吸症候群（SAS）スクリーニング陽性の患者
- 糖尿病で血糖コントロール不良が続く（歯周病の可能性）
- 誤嚥性肺炎を繰り返す在宅・施設入所患者

## 1-2　歯科→医師：こんな患者は医師へ照会・紹介しよう

### ▶ 緊急・準緊急

- 処置中・処置後に血圧異常（180/110以上、または低血圧）が出現
- 局所麻酔後のアナフィラキシー疑い（蕁麻疹・呼吸困難・血圧低下）
- 出血が止まらない（抗凝固薬・抗血小板薬服用が疑われる）
- 原因不明の疼痛・顔面腫脹（悪性疾患の除外が必要）

### ▶ 全身疾患の管理依頼・情報共有

- 糖尿病患者で抜歯・インプラントなど外科処置前の血糖コントロール確認依頼
- 骨吸収抑制薬（BP・デノスマブ）使用中患者の抜歯前MRONJ リスク評価依頼
- 抗凝固薬・抗血小板薬服用中患者の休薬・継続可否確認
- 透析患者の穿刺側（シャント側）血圧測定不可の確認

### ▶ 新規疾患の疑い・紹介

- 口腔内所見から血液疾患（白血病など）・ウイルス感染（HIV等）が疑われる
- いびき・日中の眠気・顎の小ささなどからSAS（睡眠時無呼吸症候群）が疑われる
- 顎骨・軟組織に腫瘤・潰瘍（口腔がんの疑い）→ 口腔外科・耳鼻咽喉科・内科
- 著明な乾燥・口内炎の多発 → シェーグレン症候群・ベーチェット病等の疑い

# 第2章　意外と深い！口腔と全身疾患の関わり

## 2-1　糖尿病と歯周病の双方向性

【リスク】

糖尿病患者の歯周炎リスクは非糖尿病患者の約2.6倍（2型糖尿病）。

【メカニズム】

- 高血糖 → 好中球機能低下 → 歯周組織の感染防御力低下
- 高血糖 → AGEsによる組織障害・血管障害 → 歯周組織の修復不全
- 歯周病 → TNF-α・IL-6等の炎症性サイトカイン増加 → インスリン抵抗性増大 → 血糖悪化

【エビデンス】

歯周治療（SRP）でHbA1cが約0.6%改善（12か月後）。

（強い推奨・高エビデンス：日本歯周病学会ガイドライン2023 CQ1）

【連携ポイント】

HbA1c 7.0%以上のコントロール不良例は積極的に歯科紹介。

歯科治療後もHbA1cの変化を追う。

## 2-2　脳卒中・動脈硬化

【リスク増加】

歯周病は脳梗塞リスクを約1.5〜2.6倍増加させる（コホート研究・メタ解析）。

【メカニズム】

- 歯周病原細菌（P. gingivalis等）が血流に入り内皮細胞・単球を障害
- 内頸動脈プラーク患者で抗P. intermedia抗体価が高値（菌の局所関与）
- 慢性炎症によるCRP・IL-6上昇 → 動脈硬化促進

【連携ポイント】

脳卒中既往・TIA患者や高リスク患者への口腔衛生管理を積極的に推奨。

## 2-3　認知症（アルツハイマー型）

【リスク増加】

歯周病患者はアルツハイマー型認知症リスクが約1.7倍高い（複数コホート研究）。

【メカニズム】

- P. gingivalis由来のジンジパイン（プロテアーゼ）が血液脳関門を超え脳内に侵入
- 神経毒素によるタウタンパク質の過剰リン酸化・Aβ沈着促進
- 慢性低度炎症による神経変性

【連携ポイント】

認知症ハイリスク患者・MCI患者への口腔ケア指導。残存歯数の維持も重要。

## 2-4　骨粗鬆症とMRONJ（薬剤関連性顎骨壊死）

【MRONJ定義】

骨吸収抑制薬（ビスフォスフォネート・デノスマブ）または抗血管新生薬服用中・服用後に生じる顎骨の露出・壊死。

【リスク】

BP系薬剤：静注製剤＞経口製剤。デノスマブも同等リスク。抜歯・インプラント等の侵襲的処置が誘因。

【予防の鉄則】

- 投薬開始前：必要な歯科治療（抜歯・歯周治療）を完了させる
- 投薬中：定期的な口腔衛生管理を継続（3〜4か月毎）
- 侵襲的処置前：歯科→医師への照会で薬剤情報・リスク評価を共有

【休薬について】

現時点では休薬のエビデンスは不十分。短期休薬を推奨しないが、個別に主治医と協議（日本口腔外科学会ポジションペーパー2023）。

## 2-5　睡眠時無呼吸症候群（SAS）

【歯科の役割】

SAS治療用マウスピース（口腔内装置 OAD）は軽〜中等症SASに対して保険適用（医師の診断書が必要）。

【保険診療フロー】

①内科・耳鼻科で診断（PSG検査）→②医師が歯科への依頼書を作成（診療情報提供料Ⅰ 250点）→③歯科でマウスピース製作→④定期的に効果判定・医科と情報共有

【歯科からの気づき】

いびき・歯ぎしり・夜間の口呼吸、小顎・大舌などの解剖学的特徴→SASスクリーニング（Epworth眠気尺度）後に内科・呼吸器科へ紹介

【連携ポイント】

OAD製作後も6か月毎の医科でのフォロー（AHI評価）が必要。

## 2-6　誤嚥性肺炎・周術期口腔機能管理

【誤嚥性肺炎】

口腔内細菌（嫌気性菌・連鎖球菌）が誤嚥により肺炎を起こす。口腔ケアによって誤嚥性肺炎リスクが約40%低減（エビデンスあり）。

【周術期口腔機能管理の効果】

- 術後誤嚥性肺炎の発生率低下
- 術後感染症（SSI）のリスク低下
- 入院日数短縮・医療費削減効果

【対象手術】

全身麻酔手術（消化器がん・心臓・肺・脳・整形外科等）、放射線治療・化学療法開始前が主な対象。

【医科→歯科への紹介タイミング】

手術日の2〜4週前が理想（ERAS強化回復プロトコル）。遅くても手術1週間前。